

“信東” 克黴先錠250公絲
Camisan Tablets 250mg “S.T.” (Terbinafine)

Terbinafine是Allylamine的衍生物，具廣效抗黴菌作用。對於皮膚菌(Dermatophytes)，絲黴菌(Moulds)與某些同質二形性黴菌 (Dimorphic Fungi)，在低濃度即有殺黴菌作用 (Fungicidal)。對於酵母菌類(Yeasts)的作用，則依不同的種屬而有殺黴菌或抑黴菌作用 (Fungistatic)。Terbinafine 可干擾早期黴菌麥角硬脂醇之生成，導致麥角硬脂醇 (Ergosterol) 不足，而黴菌死亡則是因為細胞內積聚了太多的 Squalene。其作用機轉是Terbinafine 抑制了黴菌細胞膜上的Squalene epoxidase。此酵素 (Squalene epoxidase) 的作用與細胞色素P450系統 (Cytochrome P450 system)無關，且Terbinafine不會影響荷爾蒙或其他藥物的代謝。從動物實驗中顯示，口服Terbinafine後，藥物集中在皮膚、頭髮及指甲上，可達到殺黴菌作用。

【成分】

主成分：每錠含：

Terbinafine(as HCl).....250mg

賦形劑：

Aerosil、HPMC 606、Microcrystalline Cellulose、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Stearate。

【適應症】

甲癬(Onychomycosis)、髮癬(Tinea Capitis)、嚴重且廣泛且經局部治療無效的皮膚黴菌感染。

【用法與用量】

本藥須由醫師處方使用。

治療時程依感染的型態及嚴重度而定：

成人

250毫克，每天服用一次。

小孩

2歲以下(體重小於12kg)，沒有口服Terbinafine的經驗，並且也不建議使用。

超過3歲以上：

體重 < 20公斤	62.5毫克一天一次
-----------	------------

體重 20~40公斤	125毫克一天一次
------------	-----------

體重 > 40公斤	250毫克一天一次
-----------	-----------

皮膚感染

足癬(趾間性、乾燥型)：2~6星期

體癬、股癬：2~4星期

皮膚念珠菌感染：2~4星期

需經過數週治療才能完全解除感染症狀。

毛髮及頭皮感染

髮癬：4星期

髮癬主要發生在小孩身上。

灰指甲

大部分患者需治療6~12星期。

手指甲黴菌感染

在大部分病例中，治療6個星期已足夠。

趾甲黴菌感染

在大部分病例中，治療12個星期已足夠。

因為長出健康指甲需要一段時間，所以沒有黴菌反應之最佳臨床效果有時會在停止治療數月之後才會顯示。

老年人

沒有證據顯示老年人的劑量須不同於年輕病人的劑量，但老年人要服用Terbinafine時，必須考慮到原先已有腎或肝功能障礙的情況。

肝或腎功能障礙者

穩定且慢性肝或腎功能異常的病人（肌胺酸酐廓清率小於50公撮／分鐘或血清肌胺酸酐大於300微莫耳／公升），應使用建議劑量的一半。

此類病人並應在用藥前後追蹤檢查其肝功能。

【注意事項】

Terbinafine用於嚴重且廣泛並經局部外用治療無效的皮膚黴菌感染時，限由皮膚科專科醫師處方使用。

口服Terbinafine須只用在外用治療無法使用時。

當病人有懷疑因下列症狀如無理由的噁心、食慾缺乏、疲倦而肝功能異常時，則須做肝功能檢查。

如果病人檢查出為肝功能不正常時或病人有明顯症候，例如：黃疸、茶尿、大便顏色蒼白時，則立刻停止使用本藥品。

患者服用藥物超過六週時，建議檢測肝功能檢查。

當病人在使用**Terbinafine**治療時，為了預防再感染，好的衛生習慣是必須的，例如：內衣、襪子、鞋子等要經常更換清洗，保持乾淨。

3歲以下的孩子，不建議使用，並且也沒有經驗。

■其他

沒有特別的症狀，像一般不舒服，頭痛，偶而有報導過，有發現幾個病例是味覺喪失(發生率為0.125%在臨床實驗中)，當停藥後，就恢復正常，也有幾個個案是肝炎及膽汁鬱滯性的肝功能異常。對已存在的慢性但穩定的肝功能異常者，如使用**Terbinafine**時，有更進一步惡化或明顯障礙的症狀時，**Terbinafine**應該停止使用。對嗜中性白血球減少症也有少數個案。

■懷孕與授乳者

胎兒毒性與受精率的動物實驗，顯示無此不良作用。懷孕者使用Terbinafine的經驗很少，建議懷孕婦女不要使用，除非使用Terbinafine可能的好處大於可能的危險性。Terbinafine會出現在乳汁中，口服使用Terbinafine者不可授乳。

■副作用

頻率的估測：非常普遍 $\geq 10\%$ ，普遍 $\geq 1\%$ 到 $<10\%$ ，不常見 $\geq 0.1\%$ 到 $<1\%$ ，稀少 $\geq 0.01\%$ 到 $<0.1\%$ ，非常稀少 $\geq 0.001\%$ 到 $<0.01\%$ 。基本上Terbinafine的耐受性良好，副作用是輕度至中度的，且是暫時性的。

非常普遍的副作用：胃腸方面，例如飽脹、噁心、消化不良、輕度腹痛、腹瀉、沒有胃口，及不是很嚴重的皮膚反應，例如：紅疹與蕁麻疹。肌肉與骨骼的反應（關節痛、肌痛）。

不常見的副作用：味覺障礙（含味覺喪失），通常停止使用本藥品數星期後即可恢復。

稀少的副作用：曾有報告指出使用Terbinafine，有肝膽障礙（本質上主要為膽汁鬱滯），包含非常稀少的肝臟衰竭個案。

非常稀少的副作用：嚴重的皮膚變化（例如：Stevens- Johnson症候群，皮膚毒性壞死）及過敏反應等都會報告過。如果皮膚反應有漸進式發展，則應該停止使用本藥品。

血液方面障礙，例如嗜中性白血球減少症、顆粒性白血球缺乏症、血小板減少症。

曾有掉頭髮的報告，但進一步的原因，還不明確。

■交互作用

根據人體外與健康受試者實驗結果，Terbinafine對經由細胞色素P450代謝的藥品(如環孢素Cyclosporin、口服避孕藥與Tolbutamide)，對其廓清率的影響微乎其微(雖然曾有病人口服Terbinafine與口服避孕藥一起服用，而有子宮出血報告)。Terbinafine的血漿廓清率可被誘導代謝藥物(如Rifampicin)提高，而抑制細胞色素P450藥物(如Cimetidine)則可降低Terbinafine的血清率。Terbinafine與上述二類藥物併用時，應調整Terbinafine的劑量。

■藥物過量

至今無藥物過量之病例報告，急性口服藥物過量的主要徵候是腸胃症狀，例如噁心或嘔吐，可以洗胃或解除症狀的支持性療法來治療。

■禁忌

對Terbinafine或其賦形劑過敏者。

【藥物動力學】

吸收

口服250公絲單一劑量，在2小時內達0.97微克／公撮($\mu\text{g}/\text{ml}$)的最高血中濃度。其吸收半衰期為1小時，分佈半衰期為4.6小時。Terbinafine與高脂肪食物併用時，由於吸收比較慢，並且有血中最高濃度及曲線下面積的關係，其生體可利用率可提高約40%。但其劑量是不須調整，除非必要時。

分佈

Terbinafine與血漿蛋白結合能力很強，可達99%，它分佈的容積超過2000升，能藉著快速擴散作用穿透真皮層而集中在親脂性的角質層中。Terbinafine也可分泌於皮脂中，因此在毛囊、頭髮與皮脂皮膚中可達到相當高的濃度。在治療的最初幾個星期後，Terbinafine也可達到指甲內。現在還是沒有足夠證據，Terbinafine是否會通過胎盤壁。而從乳汁分泌的量是少於0.2%。

代謝／排除

生體轉化後的代謝物，不具有抗黴菌作用，主要分泌在尿液中71%，糞便22%。其排除半衰期是17小時，在72小時內85%從尿中排出，腎外排除量其分數是0.29。沒有證據有蓄積作用。

在特殊臨床情況的動力學

血中穩定的狀態不會受年齡影響，基本上其生體可用率超過80%。其總血漿廓清率為1300毫升／每分鐘，但在腎或肝功能障礙者，其藥物廓清率可能降低，而致血中Terbinafine濃度較高。

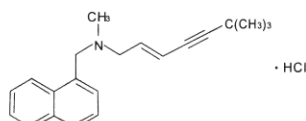
【性狀】

化學名：(E)-N-(6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-yl)-N-methyl-1-naphthalene methanamine

分子式： $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{N} \cdot \text{HCl}$

分子量：327.90

化學構造式：



【貯存】

貯存於15~30℃，密蓋容器；避光貯存。
須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

2~1,000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。
衛署藥製字第 044682 號 G-7624



信東生技股份有限公司
桃園市桃園區介壽路22號

54303770④